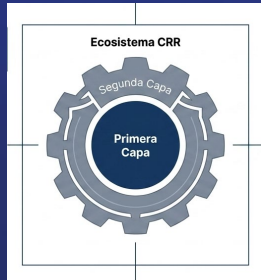
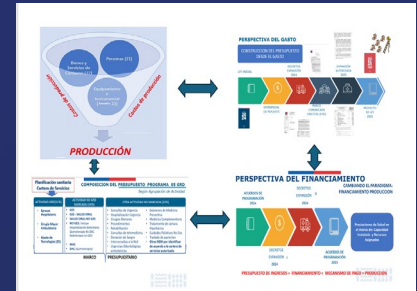


PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2026

COMITÉ FINANCIERO CLINICO



TRABAJANDO
PARA USTED



Guía Metodológica: Plan de Actividades CRR 2026

Comité de Gestión Financiero-Clínica (CGFC)



El Rol del CGFC

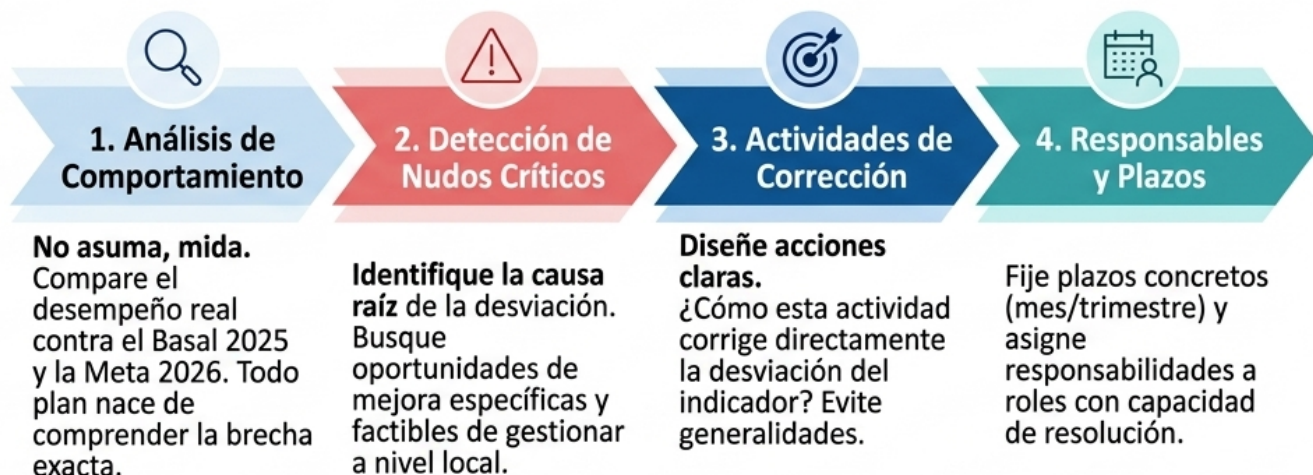
El Comité de Gestión Financiero-Clínica es el motor de la estrategia. Su propósito es evaluar la consolidación del modelo, garantizar su sostenibilidad financiera y asegurar el uso eficiente de los recursos.



Validación Requerida:

- ✓ Director(a) del Hospital
- ✓ Coordinador(a) CGFC
- ✓ Coordinador(a) CRR del Hospital

Ciclo de Gestión para la Formulación de Actividades



PLAZO DE ENTREGA: 15 DE MAYO



Directriz Fundamental: Para todos los sets de indicadores (**Capa I, Capa II y Score**), establecer actividades requiere un análisis detallado del comportamiento histórico. Las actividades deben apoyar directamente las acciones de corrección de la desviación de los objetivos, siendo **claras, enfocadas al logro, y con responsables y plazos definidos.**

Ejemplo Práctico de Llenado: Matriz de Indicadores y Plan de Corrección

Simulación de datos para demostración del estándar analítico esperado

Indicador	Meta 2026	Desempeño Actual	Análisis de Brecha (Nudo Crítico)	Actividad Correctiva	Responsable	Plazo
CAPA I - Evaluación Operativa Tasa de CMA en Pabellones CRR (Fuente: Alcor - GRD)	≥ 80%	62% ↓ (Simulado)	Resistencia al modelo ambulatorio en especialidades traumatológicas y fallos en priorización de tabla.	Reestructuración de matriz de agendamiento: bloqueo de 2 pabellones exclusivos para CMA traumatológica de baja/media complejidad.	Jefe de Pabellón / Gestor de Casos	Abril 2026
CAPA II - Seguimiento Diagnóstico % Egresos CMA Fuera de Horario	≤ 22%	35% ↑ (Simulado)	Subutilización de jornada institucional AM (08:00 - 12:00) obligando a extender cirugías fuera de jornada normal.	Auditoría semanal cruzada de rendimiento AM y redistribución de horas médicas para garantizar equipos completos a las 08:00 hrs.	Subdirección Médica	Revisión Quincenal (Inicio Inmediato)
SCORE DE ALTO RENDIMIENTO Tiempo de Recambio (min)	≤ 15 min	25 min ↑ (Simulado)	Tiempos muertos por falta de coordinación entre auxiliares de aseo y equipo de anestesia tras el egreso.	Implementación de Protocolo de Recambio Ágil (Aviso a equipo de aseo 10 minutos antes del cierre de piel) y capacitación en sala.	Enfermera Supervisora	Marzo 2026



Nota Operativa: El panel Power BI centralizado proveerá los datos basales y actuales. El esfuerzo de los equipos locales debe concentrarse exclusivamente en gestionar las columnas de Análisis, Actividades, Responsables y Plazos.

El Modelo de Dos Capas

Primera Capa (Evaluación Directa y Ranking)



Foco: Cumplimiento de producción, calidad directa y experiencia del beneficiario.



Propósito: Determina el posicionamiento y ranking del establecimiento.



Impacto: Afecta directamente el Score de Alto Rendimiento (AR) y compromisos de gestión.



Fuentes:

[ALCOR-GRD]

[DARS]

[REPORTES
CRR]

Segunda Capa (Seguimiento Diagnóstico)



Foco: Eficiencia de recursos, programación de pabellones y ausentismo.



Propósito: Visibilizar nudos críticos y oportunidades de optimización local.



Impacto: Naturaleza no punitiva; no afecta el Score AR.



Uso: Benchmarking e identificación de mejores prácticas entre nodos de la Red.

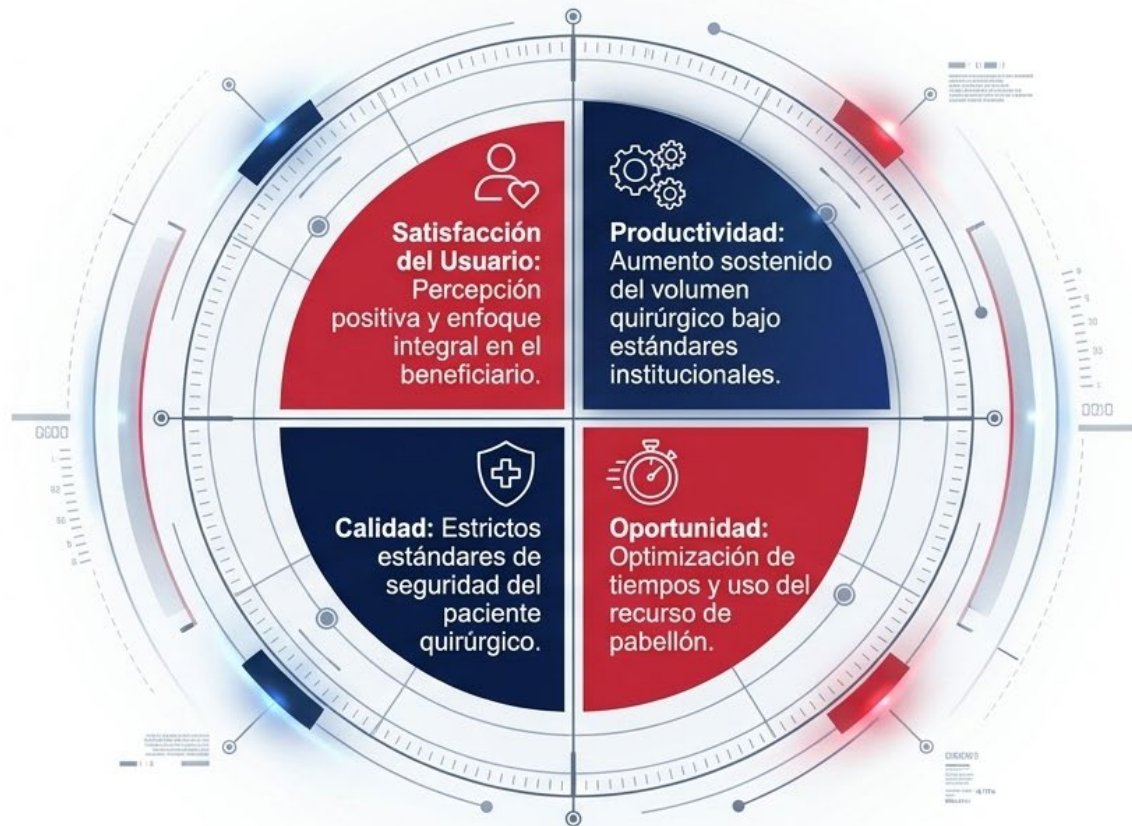
Primera Capa: El Eje de Desempeño



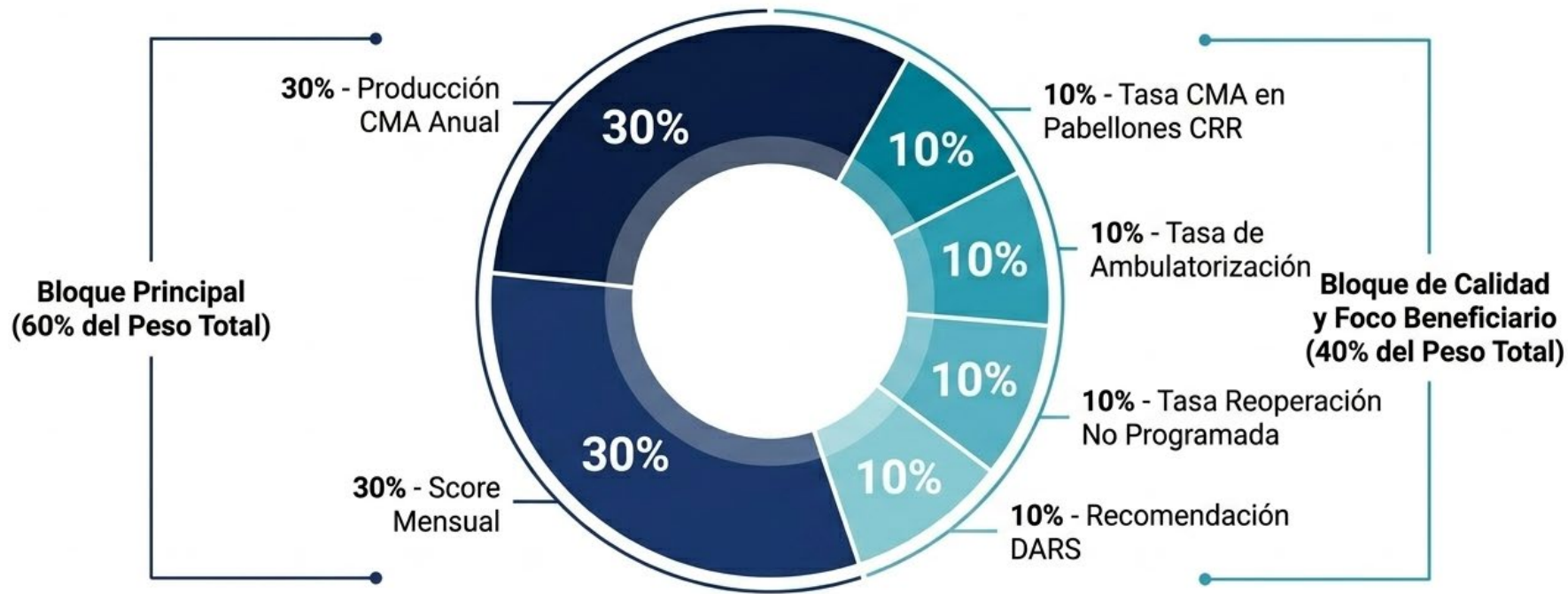
- Foco en el Score Institucional (Alto Rendimiento)
- Impacta directamente compromisos de gestión
- Mide productividad bruta, oportunidad y calidad

El Eje Central: La “Hoja de Ruta” de Primera Capa

Estos parámetros constituyen el eje central de la evaluación de desempeño operativo, seleccionados estratégicamente para medir la transformación efectiva de la capacidad resolutive.



Anatomía del Nuevo Índice de Desempeño Operativo (IDO)



El IDO equilibra el volumen puro con la seguridad clínica y la experiencia del paciente, generando un puntaje único de desempeño integral.

Componentes Críticos: Productividad y Eficiencia Operativa (60% del IDO)

**Producción CMA Anual
(Beneficiarios MAI)**

Peso IDO:
30%

100%

Meta Global

[ALCOR - GRD]

Foco: El motor principal de la estrategia, alineado directamente con las metas financieras 2026.

Score Mensual

Peso IDO:
30%

>15% del Basal ó >= 13 Pts

Meta Global

[Reporte Pabellones
CRR Semanal]

Foco: Mide la constancia y el ritmo de alto rendimiento mes a mes, evitando caídas estacionales bruscas.

**Producción CMA Anual
(Beneficiarios MAI)**

Peso IDO:
30%

100%

Meta Global

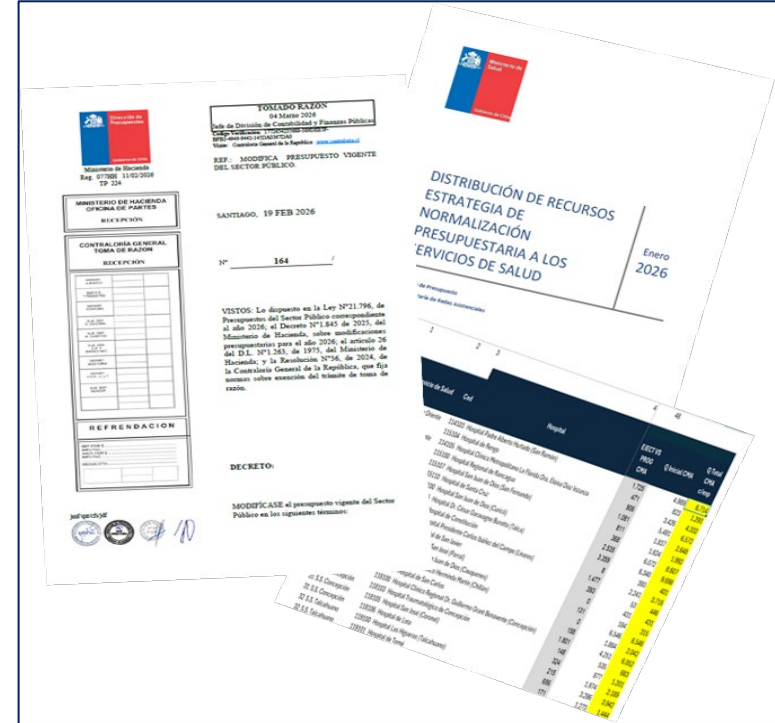
[ALCOR - GRD]

Foco: El motor principal de la estrategia, alineado directamente con las metas financieras 2026.

ACUERDO DE PROGRAMACION LEY INICIAL

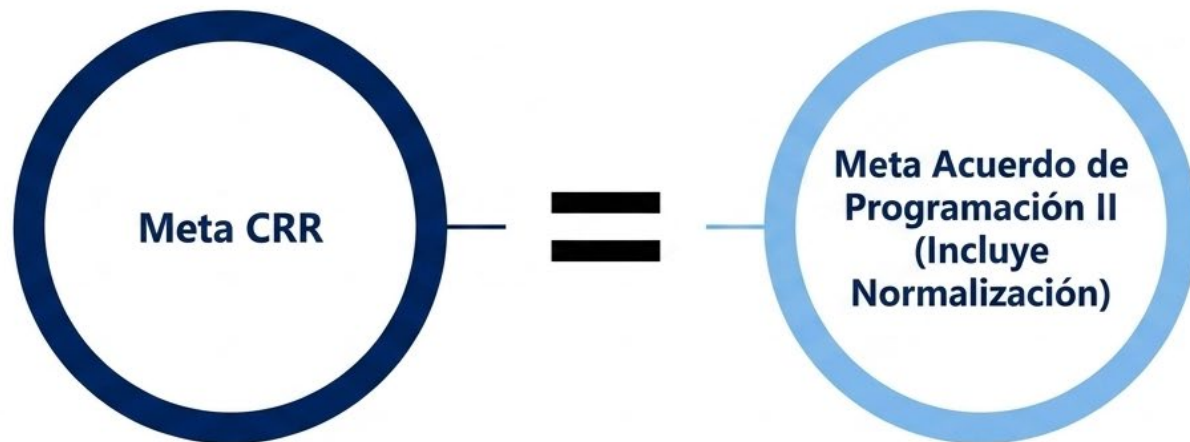


DECRETO DE EXPANSION NORMALIZACION N°164/2026



El Desafío 2026: Convergencia Estratégica y Financiera

Por primera vez, la estrategia sanitaria se alinea totalmente con el mecanismo de financiamiento.



Definición Única: La cantidad y peso GRD que constituye la Meta CRR 2026 es exactamente la cifra del Acuerdo II de Programación (FNS). Su cumplimiento exige un control operativo milimétrico.

DETALLE DE CONSTRUCCION DE RECURSOS NORMALIZACION CMA N°164/2026

ACUERDO
PROGRAMACION
LEY

DECRETO DE
EXPANSION
NORMALIZA
CION
N°164/2026

META CRR

Servicio de Salud	Cod	Hospital	Q Total CMA Lev	EJECT 2025 VS PROG CMA	Q Total CMA c/exp
S.S. Arica y Parinacota	101100	Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	3.330	0	3.330
S.S. Antofagasta	103100	Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	3.587	1.362	4.949
S.S. Atacama	104100	Hospital San José del Carmen (Copiapó)	2.720	0	2.720
S.S. Coquimbo	105100	Hospital San Juan de Dios (La Serena)	6.234	115	6.349
S.S. Coquimbo	105101	Hospital San Pablo (Coquimbo)	3.903	0	3.903
S.S. Valparaíso-San Antonio	106103	Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	2.527	845	3.371
S.S. Viña del Mar-Quillota	107100	Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	5.007	0	5.007
S.S. Viña del Mar-Quillota	107101	Hospital San Martín (Quillota)	5.421	1.427	6.848
S.S. Met. Occidente	110120	Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	4.719	601	5.321
S.S. Met. Central	111101	Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada	3.241	0	3.241
S.S. Met. Sur Oriente	114103	Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	4.989	1.725	6.714
S.S. O'Higgins	115100	Hospital Regional de Rancagua	5.491	1.081	6.572
S.S. Maule	116100	Hospital San Juan de Dios (Curicó)	6.072	2.535	8.607
S.S. Maule	116105	Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	6.340	3.359	9.698
S.S. Ñuble	117101	Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán)	6.546	0	6.546
S.S. Concepción	118100	Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	4.251	1.801	6.052
S.S. Talcahuano	119100	Hospital Las Higueras (Talcahuano)	3.286	656	3.942
S.S. Biobío	120101	Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Angeles)	6.392	0	6.392
S.S. Araucanía Sur	121121	Hospital de Villarrica	2.012	1.149	3.161
S.S. Los Ríos	122100	Hospital Clínico Regional (Valdivia)	4.541	374	4.914
S.S. Osorno	123100	Hospital Base San José de Osorno	2.829	810	3.639
S.S. Reloncaví	124105	Hospital de Puerto Montt	6.407	1.029	7.436
S.S. Aysén	125100	Hospital Regional (Coihaique)	1.396	0	1.396
S.S. Magallanes	126100	Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta Arenas)	2.554	440	2.994
S.S. Araucanía Sur	200717	Hospital Padre Las Casas	3.199	712	3.911



TRABAJANDO PARA USTED

CIRUGÍAS MAYORES AMBULATORIAS 2026

				ACUERDO DE PROGRAMACION INICIAL FONASA SS REDES 2026		META CRR = Nueva META AP después que se trámite el Decreto Normalización Ord. N°.1.903/2026			
Estrategia	Cod	Hospital	FF	Q inicial CMA 2026	PM Prog 2026 (5)	Nuevo Q CMA 2026	PM Prog 2025	UPH***	
CRRi	201319	Hospital de Alto Hospicio*	PPI	2.016	0,56	2.016	0,56	1.129	
CRRi	200282	CRS Hospital Provincia Cordillera*	PPI	2.809	0,64	2.809	0,64	1.798	
CRRi	105100	Hospital San Juan de Dios (La Serena)	GRD	6.234	0,50	6.349	0,50	3.199	
CRRi	107100	Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	GRD	5.007	0,53	5.007	0,53	2.671	
CRRi	107101	Hospital San Martín (Quillota)	GRD	5.421	0,55	6.848	0,55	3.772	
CRRi	121121	Hospital de Villarrica	GRD	2.012	0,58	3.161	0,58	1.847	
CRRi	200717	Hospital Padre Las Casas	GRD	3.199	0,67	3.911	0,67	2.621	
CRR 16	103100	Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	GRD	3.587	0,44	4.949	0,44	2.198	
CRR 16	104100	Hospital San José del Carmen (Copiapó)	GRD	2.720	0,42	2.720	0,42	1.153	
CRR 16	105101	Hospital San Pablo (Coquimbo)	GRD	3.903	0,54	3.903	0,54	2.121	
CRR 16	106103	Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	GRD	2.527	0,49	3.371	0,49	1.658	
CRR 16	110120	Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	GRD	4.719	0,51	5.321	0,51	2.701	
CRR 16	111101	Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada	GRD	3.241	0,72	3.241	0,72	2.346	
CRR 16	114103	Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	GRD	4.989	0,53	6.714	0,53	3.582	
CRR 16	115100	Hospital Regional de Rancagua	GRD	5.491	0,58	6.572	0,58	3.830	
CRR 16	116100	Hospital San Juan de Dios (Curicó)	GRD	6.072	0,53	8.607	0,53	4.580	
CRR 16	116105	Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	GRD	6.340	0,60	9.698	0,60	5.820	
CRR 16	118100	Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	GRD	4.251	0,69	6.052	0,69	4.159	
CRR 16	119100	Hospital Las Higueras (Talcahuano)	GRD	3.286	0,73	3.942	0,73	2.892	
CRR 16	120101	Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Angeles)	GRD	6.392	0,60	6.392	0,60	3.819	
CRR 16	123100	Hospital Base San José de Osorno	GRD	2.829	0,58	3.639	0,58	2.107	
CRR 16	124105	Hospital de Puerto Montt	GRD	6.407	0,58	7.436	0,58	4.335	
CRR 16	126100	Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta Arenas)	GRD	2.554	0,55	2.994	0,55	1.637	
CRR 2025	101100	Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	GRD	3.330	0,46	3.330	0,46	1.535	
CRR 2025	117101	Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán)	GRD	6.546	0,54	6.546	0,54	3.548	
CRR 2025	122100	Hospital Clínico Regional (Valdivia)	GRD	4.541	0,52	4.914	0,52	2.541	
CRR 2025	125100	Hospital Regional (Coihaique)	GRD	1.396	0,48	1.396	0,48	667	
TOTAL				-	111.818	0,56	131.838	0,56	74.266
Notas:									
* Mantienen Meta AR Glosa 29 - Sin aumento de Recursos 2026									
*** UPH Indicador de Financiamiento equilibrado según recursos autorizados. Combina N° CMA * Peso Medio GRD									



Proyección Mensualizada 2026: Metas de Cirugías Mayores (CMA)

Modelo de Optimización con Restricción Anual y Ajuste Estacional (Basado en Comportamiento Histórico)



META ANUAL

Restricción Total de Cirugías

—



ENERO

Base Real Efectiva

=



VOLUMEN RESTANTE A DISTRIBUIR

El remanente de cirugías se distribuye entre Febrero y Diciembre. **NO** se realiza de forma lineal (+ 11), sino aplicando ponderadores estacionales (W) para garantizar metas operativamente alcanzables.



Proyección Mensualizada 2026: Metas de Cirugías Mayores (CMA)

Modelo de Optimización con Restricción Anual y Ajuste Estacional (Basado en Comportamiento Histórico)

CODIGO HOS/HOSPITAL (DIPRES)	Enero*	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
101100 Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	263	223	278	278	292	292	278	292	250	328	306	250	3330
103100 Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	243	342	427	427	449	449	427	449	385	496	470	385	4949
104100 Hospital San José del Carmen (Copiapó)	171	185	231	231	243	243	231	243	208	272	254	208	2720
105100 Hospital San Juan de Dios (La Serena)	621	416	520	520	546	546	520	546	468	606	572	468	6349
105101 Hospital San Pablo (Coquimbo)	372	256	321	321	337	337	321	337	288	372	353	288	3903
106103 Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	263	226	282	282	296	296	282	296	254	330	310	254	3371
107100 Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	227	347	434	434	456	456	434	456	391	503	478	391	5007
107101 Hospital San Martín (Quillota)	449	465	581	581	610	610	581	610	523	676	639	523	6848
110120 Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	398	358	447	447	469	469	447	469	402	521	492	402	5321
111101 Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada	232	218	273	273	287	287	273	287	246	319	300	246	3241
114103 Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	607	444	555	555	582	582	555	582	499	644	610	499	6714
115100 Hospital Regional de Rancagua	335	453	567	567	595	595	567	595	510	655	623	510	6572
116100 Hospital San Juan de Dios (Curicó)	710	574	717	717	753	753	717	753	646	832	789	646	8607
116105 Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	624	659	824	824	866	866	824	866	742	954	907	742	9698
117101 Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán)	369	449	561	561	589	589	561	589	505	651	617	505	6546
118100 Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	436	408	510	510	536	536	510	536	459	591	561	459	6052
119100 Hospital Las Higueras (Talcahuano)	255	268	335	335	351	351	335	351	301	391	368	301	3942
120101 Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Angeles)	310	442	552	552	580	580	552	580	497	642	608	497	6392
121121 Hospital de Villarrica	308	207	259	259	272	272	259	272	233	302	285	233	3161
122100 Hospital Clínico Regional (Valdivia)	370	330	413	413	433	433	413	433	371	480	454	371	4914
123100 Hospital Base San José de Osorno	257	245	307	307	322	322	307	322	276	360	338	276	3639
124105 Hospital de Puerto Montt	398	511	639	639	671	671	639	671	575	744	703	575	7436
125100 Hospital Regional (Coihaique)	90	94	118	118	124	124	118	124	106	144	130	106	1396
126100 Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta Arenas)	198	203	254	254	266	266	254	266	228	298	279	228	2994
200282 CRS Hospital Provincia Cordillera	165	192	240	240	172	252	240	252	216	280	264	216	2729
200717 Complejo Asistencial Padre Las Casas	343	259	324	324	340	340	324	340	291	379	356	291	3911
201319 Hospital de Alto Hospicio	92	139	174	174	183	183	174	183	157	208	192	157	2016
Total general	9106	8913	11143	11143	11620	11700	11143	11700	10027	12978	12258	10027	131758

Modificadores de Calidad y Experiencia del Beneficiario (40% del IDO)



Tasa de CMA en Pabellones CRR

**Aumentar a 20% del
basal 2025 ó $\geq 80\%$**

[Reporte Pabellones / ALCOR]

Peso IDO:
10%



Tasa de Ambulatorización

$> 70\%$

(CMA Electivas / Total Mayores Electivas) x 100

[ALCOR - GRD]

Peso IDO:
10%



Tasa Reoperación No Programada

$< 1\%$

[Reporte Calidad CRR Semanal]

Peso IDO:
10%



Recomendaría a un Familiar

$\geq 95\%$

(Respuestas 'Muy bueno' y 'Bueno')

[Reporte DARS]

Peso IDO:
10%



Panel Institucional: Ranking Dinámico de Desempeño por CRR

Herramienta de gestión central para focalizar intervenciones en terreno basada en el IDO consolidado.

	CRR Node	Producción (30%)	Score (30%)	Ambulatorización (10%)	Calidad (30% sum)	IDO Total	Estado
1	Hospital Norte	98%	15 Pts	75%	Cumple	92%	[LÍDER]
2	Hospital Centro	85%	13 Pts	65%	Cumple	78%	[OBSERVACIÓN]
3	Hospital Sur	60%	9 Pts	72%	Falla (<1% Reop)	45%	[INTERVENCIÓN]



Insight: El panel permite diseccionar el rendimiento: un centro puede tener alto volumen (verde), pero **fallar críticamente** en calidad (rojo), activando protocolos de soporte específicos.

Protocolo de Acción: Focalización del Trabajo en Terreno

**Tier 1:
Alto Desempeño
(Verde)**



Acción: Monitoreo pasivo y extracción de Mejores Prácticas.

Objetivo: Estandarizar sus procesos exitosos para exportarlos al resto de la red.

**Tier 2:
Rendimiento Medio
(Amarillo)**



Acción: Soporte digital dirigido y auditoría remota.

Objetivo: Corregir desviaciones específicas (ej. leve caída en ambulatorización) antes de que impacten el volumen.

**Tier 3:
Bajo Desempeño
(Rojo)**



Acción: Despliegue de Trabajo en Terreno (TET).

Objetivo: Intervención directa del nivel central. Reestructuración de la gestión local, destrabe de nudos críticos en pabellón y levantamiento urgente de alertas.

Segunda Capa: El Eje Diagnóstico



- Foco en Monitoreo y Mejora Continua
- No afecta el score institucional
- Mide eficiencia interna, trazabilidad y sostenibilidad del modelo

Premisas de la Segunda Capa



Naturaleza Mejora continua: Su propósito es visibilizar nudos críticos y oportunidades de optimización en la gestión local.



Centralización de la información: Datos procesados centralmente para asegurar independencia analítica y reducir la carga administrativa local.



Benchmarking y Aprendizaje: Establecimiento de estándares comparativos en la red para identificar mejores prácticas y unificar criterios técnicos.



Optimización de Recursos

% Pabellones Comprometidos

Índice de Ausentismo Quirúrgico (IA Qx)



Fidelidad al Modelo Operativo

% Egresos CMA Fuera de Horario

% Actividad No CMA



Sostenibilidad Financiera y Sanitaria

Paquetización (Costo Insumos)

Tasa Egresos Oncológicos

La Segunda Capa agrupa 6 métricas clave en 3 ejes estructurales para proteger la capacidad resolutive de la red.

Indicador:
**% Pabellones
Comprometidos**

Meta: $\geq 95\%$

Fuente: Reporte Pabellones
CRR Semanal



Evaluación: Mide la relación entre los bloques diarios efectivamente utilizados versus los asignados.



Foco de Acción: Brechas significativas por debajo de la meta visibilizan capacidad ociosa o cuellos de botella en la programación que retrasan la oportunidad de atención.

Pilar 2 - Gestión del Tiempo Institucional

Indicador: % Egresos CMA Fuera de Horario | **Meta:** $\leq 22\%$ | **Fuente:** ALCOR GRD



- Este indicador resguarda que la actividad quirúrgica resida prioritariamente en la jornada habitual institucional.
- El margen del 22% absorbe la dinámica del mix productivo y limita la sobredependencia de compras de servicios eventuales, forzando la optimización de la jornada ordinaria.

Pilar 3 - Trazabilidad y Sostenibilidad Financiera

Indicador: Paquetización (Costo Medio Insumos Clínicos) | **Meta:** $\leq 20\%$ | **Fuente:** Sistema de Costos - SIGCOM



Paquetización (Costo Medio de Insumos):

- Resultados de carácter referencial enfocados en la mejora de la asertividad y calidad de la tributación en el sistema de costos.
- Al abarcar la **estandarización del 60% de las prestaciones CMA más frecuentes**, se mantiene como indicador de monitoreo hasta la estabilización del registro.
- Una vez depurada la captura de datos, el impacto en la eficiencia y la reducción de la variabilidad clínica será plenamente representativo.

⚠ ALERTA ESTRATÉGICA

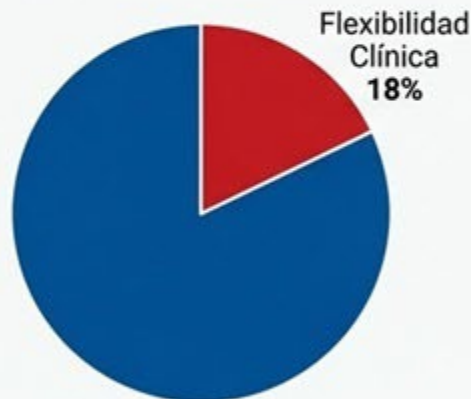
En esta etapa se mide el impacto financiero, pero el objetivo principal no es solo perseguir la baja del costo medio, sino **sumarse a la estandarización clínica y sus beneficios**.

Este indicador funciona como un panel de monitoreo del estado del arte de dicha estandarización.

Pilar 4 - Coherencia del Modelo y Talento Humano

Adherencia al Modelo

% Actividad No CMA en Pabellones CRR ▶ Meta: $\leq 18\%$



Asegura la fidelidad al modelo CMA de Alto Rendimiento. El 18% otorga flexibilidad clínica. Superar este umbral sugiere una desnaturalización del perfil de producción del pabellón y exige revisión de pertinencia médica local.

Continuidad del Talento

Índice de Ausentismo Quirúrgico CRR ▶ Meta: $\leq$ Basal 2025



Indicador de transición. Mantiene seguimiento local sobre la dotación de pabellón mientras se avanza hacia la homogeneización nacional de fuentes (SIRH, Qlikview).

Pilar 5 - Equilibrio de Prioridad Sanitaria

Indicador: Tasa de Egresos Qx asociado a Diagnóstico Oncológico (CIE-10)

Meta: $\geq$ Basal 2025 | Fuente: ALCOR GRD



- El éxito de la estrategia CMA no ocurre en el vacío. Este indicador actúa como un candado de seguridad institucional.
- Garantiza que la aceleración operativa en pabellones ambulatorios sea complementaria y no desplace la capacidad resolutive vital para intervenciones oncológicas priorizadas.

Matriz Diagnóstica: Indicadores de Seguimiento (Segunda Capa)

Panel 1: Optimización de Recursos y Eficiencia



**% Pabellones
Comprometidos**

Meta $\geq 95\%$

(Mide capacidad ociosa y uso efectivo de bloques)



**% Egresos Fuera
de Horario**

Meta $\leq 22\%$

(Resguarda el uso de jornada ordinaria institucional, 8:00 a 16:59 hrs)



**Índice de
Ausentismo Qx**

Meta $\leq$ Basal 2025

(Monitoreo de recurso humano)



**Paquetización
(Costo Medio)**

Meta $\leq 20\%$

(Transición hacia registro SIGCOM para homogenizar costos)

Panel 2: Pertinencia y Perfil Quirúrgico



**% Actividad No CMA
en CRR**

Meta $\leq 18\%$

(Evita la desnaturalización del modelo ambulatorio)



**Tasa Egresos Dx
Oncológico**

Meta $\geq$ Basal 2025

(Asegura que la eficiencia CMA no desplace la cirugía oncológica compleja)

Anexo Técnico: Notas Explicativas y Observaciones de Captura

Clasificación de Jornada Laboral (Aplica al Indicador 1)		
Días de la Semana	Horario	Clasificación
Lunes a Jueves	08:00 a 16:59	HORARIO INSTITUCIONAL
Viernes	08:00 a 15:59	HORARIO INSTITUCIONAL
Lunes a Jueves	17:00 en adelante	FUERA DE JORNADA
Viernes	16:00 en adelante	FUERA DE JORNADA
Lunes a Viernes	Antes de las 08:00	FUERA DE JORNADA
Sábado y Domingo	Todo el día	FUERA DE JORNADA

Ítem de Costos Clínicos (Aplica al Indicador 2 - Paquetización)
Listado de tributación a considerar: Materiales de Odontología, Insumos de Osteosíntesis y Prótesis, Material Médico Quirúrgico, Insumos de Curación.

La implementación de este Modelo de Dos Capas es, ante todo, un proceso y un recorrido que haremos juntos.



Realismo y Ambición

- Nos hemos fijado metas altas para asegurar el ritmo de alto rendimiento que exige la estrategia 2026.
- Sin embargo, la premisa fundamental es clara: **nadie está obligado a lo imposible.**



Transparencia Sin Miedo

- Sinceren e incorporen los **nudos críticos** reales que enfrenta cada Centro Regional de Resolución (CRR).
- Medir la Primera y Segunda Capa **no es punitivo**; es nuestro motor exclusivo para la **mejora continua.**



Fuerza, Talento y Red

- Poner las alertas sobre la mesa permite al nivel central y local buscar soluciones reales y generar un **aprendizaje cruzado.**
- El éxito de la red quirúrgica descansa en **su capacidad y compromiso.** Trabajemos unidos para consolidar este modelo.

Muchas gracias por su dedicación y el tremendo talento demostrado.



Gobierno
de Chile

gob.cl

TRABAJANDO PARA USTED

